

CRISE DE ASMA

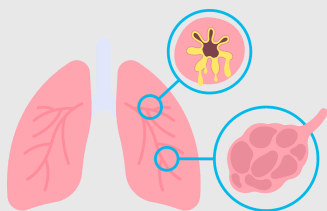


ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

ASMA

- A asma é uma das doenças mais comuns em países desenvolvidos e tem uma prevalência mundial entre 7 a 10%.
- No Brasil, estima-se que há cerca de **20 milhões de asmáticos**.
- Dados de 2015 (DATASUS) registraram 113.700 internações hospitalares por exacerbação de asma, com registro de 543 mortes (em redução: habitual é 2000 mortes/ano, porém ainda é elevado, pois são **mortes preveníveis**).



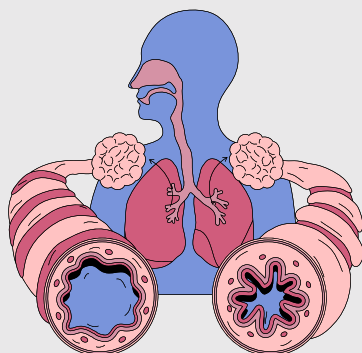
ASMA

- É uma doença heterogênea, caracterizada por **inflamação crônica** das vias aéreas, caracterizada por **exacerbações** de dispneia, tosse, sibilos, obstrução variável e **hiperresponsividade** das vias aéreas.
- **Exacerbações ou crises são definidas como** episódios de **piora** (progressiva e/ou aguda) dos sintomas, além das variações já usuais durante o dia. Representam uma **mudança nos sintomas e na função pulmonar** do paciente.



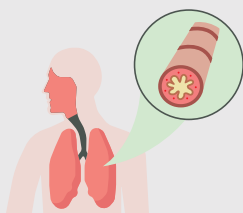
ASMA

- **Fisiopatologia:** complexa e envolve diversos mecanismos. O mecanismo mais importante é a **inflamação crônica das vias aéreas**.
- A inflamação da submucosa, com **hiperirritabilidade** da musculatura lisa das vias aéreas, pode ser **precipitada** por alérgenos, poeira, agentes químicos, infecções e fatores não identificados.



ASMA

- **Fatores precipitantes de crise aguda:**
 - Infecções virais (80% dos casos);
 - Exposição a aeroalérgenos e mudanças climáticas;
 - Infecções bacterianas;
 - Medicações (AAS, betabloqueadores);
 - Estresse emocional;
 - Exercício físico;
 - DRGE.
-
- **Quadro Clínico:** dispneia, opressão torácica e sibilância (pelo menos um desses sintomas é relatado em 90% dos pacientes). Tosse é sintoma comum.



ASMA

- **Gravidade das exacerbações:**
- **Leve:** paciente fala sentenças, é capaz de deitar, taquipneico (porém < 30 irpm), **sem uso de musculatura acessória** (normalmente), sibilos expiratórios moderados, FC < 100 bpm, paciente pode estar agitado ou sem alteração do estado mental, **Sat.O2 > 94/95%.**
- **Moderada:** dispneia ao falar, fala apenas frases, taquipneico (porém < 30 irpm), **uso de musculatura acessória**, sibilos expiratórios difusos, FC 100 – 120 bpm, agitado, **Sat.O2: 91 – 95%.**



ASMA

- **Grave:** dispneia ao repouso, fala apenas palavras, incapaz de deitar, taquipneico ($FR > 30$ irpm), uso de musculatura acessória, sibilos inspiratórios e expiratórios, $FC > 120$ bpm, agitação e $Sat.O_2 < 90\%$.
- **Eminência de PCR:** incapaz de falar, respiração paradoxal, **tórax silencioso**, bradicardia, confusão mental ou sonolência.



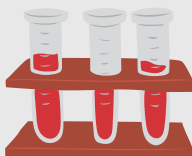
ASMA

- A abordagem do paciente com crise de asma precisa ser **rápida e efetiva**.
- Inicialmente, é fundamental realizar o reconhecimento do diagnóstico e classificação de gravidade.
- Devo solicitar exames? Depende da classificação de gravidade. **O diagnóstico da exacerbação aguda é clínico!!**
- Quando solicitar? Nos casos de asma grave, com indicação de internação hospitalar. Os exames auxiliam na complementação da avaliação da gravidade, identificação de complicações e fatores precipitantes.



ASMA

- **O que solicitar?**
- Gasometria Arterial: indicada em pacientes com **desconforto respiratório importante** (exacerbação grave), $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ é indicativo de gravidade*.
- Hemograma: em pacientes **febris**, com **expectoração purulenta**.
- ECG: em pacientes **cardiopatas**, com DPOC associada e idade superior a 50 anos.
- Eletrólitos: se indicação de internação.



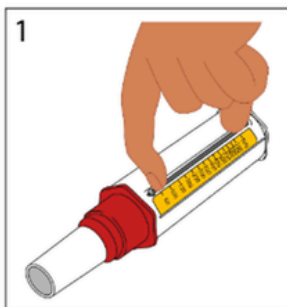
ASMA

- **Radiografia de tórax:** solicitar nos casos de **suspeita de pneumonia, pneumotórax, derrame pleural**; nos pacientes com **indicação de internação e sem melhora esperada** com o tratamento.
- E o **Peak-Flow** (pico de fluxo)? É indicado em todos os pacientes com exacerbação aguda no serviço de emergência (realizado idealmente a cada hora). Auxilia no **manejo e plano terapêutico**, além de ser importante na avaliação da possibilidade de alta hospitalar. É capaz de detectar **obstrução do fluxo** de ar **mais grave** do que os sintomas ou o exame físico indicam.



ASMA

Como medir a taxa de pico de fluxo expiratório (TPFE)



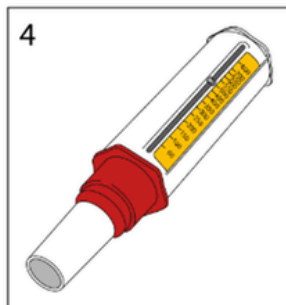
Mova o marcador para a base da escala numerada.



- Levantar e fazer uma inspiração profunda.
- Segurar a respiração e colocar o bocal entre os lábios.
- Fechar os lábios em volta do bocal.



Expirar o mais forte e rápido possível (manter os dedos longe da escala).



- Registrar o resultado.
- Mover o marcador de volta a base e repetir 2 vezes. Usar o resultado mais elevado das 3 medidas.

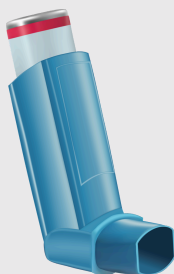
Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado: Asma



ROTINA CLÍNICA

ASMA

- O tratamento deve ser **imediate** (seja na UBS, UPA ou PS), sendo os **β_2 agonistas** de curta ação o grupo de medicações mais importante na terapêutica. Esse grupo de medicações, sendo o **Salbutamol** o mais utilizado e disponível, representa a “pedra fundamental” do tratamento do paciente com crise/exacerbação de asma.
- Demais detalhes do tratamento estão apresentados no guia de prescrições!



REFERÊNCIAS

- Asma – Medicina de Emergência USP 17ª Edição.
- Global Initiative for Asthma (GINA) 2023.
- Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado: Asma.



ROTINA CLÍNICA